

# PHOENIX evaluatiestudie

## Fase 1 – onafhankelijke expertgeneratie

### *Instrument voor Zorgprofessionals*

#### Deelnemerscode: HCP-PRE-03

Toegewezen casus: **C03** (41-jarige leraar secundair onderwijs)

|                       |                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Studie</b>         | Evaluatie van de klinische kwaliteit van een ontologiegebaseerd multi-agentsysteem voor gepersonaliseerde digitale geestelijke gezondheidszorg |
| <b>Instelling</b>     | Universiteit Gent – Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen                                                                        |
| <b>Onderzoeker</b>    | Stijn Van Severen (masterproefstudent)                                                                                                         |
| <b>Promotoren</b>     | Prof. Dr. Geert Crombez; Dr. Annick De Paepe                                                                                                   |
| <b>Contact</b>        | <a href="mailto:stijn.vanseveren@ugent.be">stijn.vanseveren@ugent.be</a>                                                                       |
| <b>Geschatte duur</b> | Ongeveer 20–25 minuten voor de casus (inclusief leestijd instructies)                                                                          |

#### Doel van deze bundel

U neemt deel aan een evaluatiestudie waarin zorgprofessionals onafhankelijk dezelfde vijf klinische redeneerstappen uitvoeren als een geautomatiseerd multi-agentsysteem. Uw antwoorden vormen het menselijke referentiecorpus voor een latere dubbelblinde vergelijking met systeemoutput.

Voor uw casus vult u dezelfde vijf delen in: (1) operationalisering, (2) initieel observatiemodel, (3) prioritering van behandeldoelen, (4) verfijning van EMA-metingen en (5) een mobiele coachingsboodschap.

**We vragen uw eigen klinische oordeelsvorming.** Antwoord zoals u dat in een reële professionele context zou doen, maar werk strikt volgens de instructies op de volgende pagina.

**Vertrouwelijkheid:** uw antwoorden worden voor analyse geanonimiseerd en uitsluitend gebruikt binnen deze masterproefstudie. Deelname is vrijwillig; u kan zich op elk moment terugtrekken door contact op te nemen met de onderzoeker.

## Contents

---

|          |                                                                               |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Instructiepagina</b>                                                       | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Deel 1: Operationalisering van de mentale gezondheidstoestand</b>          | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>Deel 2: Initieel observatiemodel (bipartiet netwerk)</b>                   | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Deel 3: Behandeldoelprioritering via het bipartiet netwerk</b>             | <b>9</b>  |
| <b>5</b> | <b>Deel 4: Verfijnd observatiemodel – selectie van sub-behandelingsopties</b> | <b>11</b> |
| <b>6</b> | <b>Deel 5: Gepersonaliseerde mobiele coachingsboodschap (HAPA-kader)</b>      | <b>13</b> |
| <b>7</b> | <b>Afronding en terugbezorging</b>                                            | <b>15</b> |

# 1 Instructiepagina

## Het PHOENIX-systeem en de context van deze studie

**PHOENIX** (Personalized Hierarchical Optimization Engine for Navigating Insightful eXplorations) is een multi-agentsysteem ontwikkeld als onderdeel van een masterproef in de psychologie aan de Universiteit Gent. Het systeem verwerkt een vrije klachttekst en doorloopt vijf opeenvolgende klinische redeneerstappen die de kern vormen van een gepersonaliseerde, longitudinale digitale interventie.

Het theoretische kader van PHOENIX steunt op het **netwerk-analytisch model van psychopathologie**: psychische klachten worden niet als uitingen van een latente stoornis beschouwd, maar als een *dynamisch netwerk van onderling samenhangende klachtcomponenten*. Een sleutelbegrip daarbinnen is het onderscheid tussen **symptomen** (klacht- en toestandsdimensies die beschrijven wat er mis gaat bij de persoon) en **behandelingsopties** (modificeerbare gedragsvariabelen die de symptomen causaal beïnvloeden en als behandeldoel kunnen dienen).

### Kerndefinities: symptoom versus behandelingsoptie

**Symptoom (S)**: een klinisch relevante, momentaan aanwezige *klacht- of toestandsdimensie* van de persoon die herhaald meetbaar is via dagelijkse EMA. Symptomen zijn de *uitkomstvariabelen* in het netwerk – ze beschrijven *wat er mis gaat* (bijv. inslaapproblemen, paniekepisoden, sombere stemming). Symptomen zijn geen gedragingen of interventies.

**Behandelingsoptie (BO)**: een *modificeerbare gedrags- of procesvariabele* die plausibel causaal ingrijpt op een of meerdere symptomen en dagelijks meetbaar is via een korte EMA-vraag. Behandelingsopties zijn de *ingreepvariabelen* in het netwerk – ze beschrijven *wat veranderbaar is* (bijv. avondschermtijd, geplande exposure, aerobe beweging). Een behandelingsoptie is *nooit een symptoom zelf*, maar een gedrag, strategie of omgevingsfactor die het symptoom beïnvloedt.

*Voorbeelden ter verduidelijking:*

- **Symptoom**: inslaapproblemen, anticipatieangst, anergie, piekeren voor het slapengaan.
- **Behandelingsoptie**: avondschermtijd (min), geplande exposurestap (ja/nee), bewegingsfrequentie (min), preslaap-offloading (ja/nee).

### Ecological Momentary Assessment (EMA) – basisprincipes

**EMA** is een methode waarbij personen vaak meerdere keren per dag hun actuele toestand of gedrag rapporteren via een mobiele applicatie. In PHOENIX wordt EMA gebruikt om zowel symptomen als behandelingsopties dagelijks te monitoren over een periode van meerdere weken.

Een goede EMA-variabele voldoet aan vier vereisten:

- **Dagelijks rapporteerbaar**: via een korte vraag op de smartphone, bijv. (ja/nee, aantal, minuten of 0–10).
- **Dynamisch en veranderbaar**: geen vaste trek, diagnose of stabiel achtergrondkenmerk.
- **Klinisch relevant**: toont binnen-persoonsvariatie die therapeutisch informatief is.
- **Onderscheid symptoom vs. behandelingsoptie**: klachtdimensies zijn symptomen; modificeerbare gedragingen zijn behandelingsopties.

### Het bipartiet netwerk: structuur van het observatiemodel

Na 21 dagen EMA-monitoring construeert PHOENIX een **bipartiet netwerk**: een graaf met twee kolommensets en gewogen verbindingen daartussen.

- **Linkse kolom – Behandelingsopties (BO)**: de modificeerbare variabelen.

- **Rechtse kolom – Symptomen (S):** de klacht- en toestandsdimensies.
- **Kanten:** de richting loopt van behandelingsoptie naar symptoom (BO → S). Een *blauwe* rand duidt op een positief verband (behandelingsoptie vergroot het symptoom), een *rode* rand op een negatief verband (behandelingsoptie verkleint het symptoom). Lijndikte is proportioneel aan de sterkte van het empirische verband uit de monitoringdata.

In **Deel 3** rangschikt u de behandelingsopties op behandelprioriteit op basis van dit netwerk en de monitoringsamenvatting.

## Overzicht van de vijf taken

| Stap             | Klinische taak           | Wat u doet                                                                       | Richttijd |
|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| —                | Instructies lezen        | Lees de instructiepagina aandachtig door                                         | ≈ 5 min   |
| 1                | Operationalisering       | Identificeer 2–6 <b>symptoomlabels</b> (klachtdimensies)                         | ≈ 3 min   |
| 2                | Initieel observatiemodel | Genereer 3–5 <b>behandelingsoptielabels</b> (modificeerbaar, EMA-geschikt)       | ≈ 3 min   |
| 3                | Behandeldoelprioritering | Rangschik alle 5 <b>behandelingsopties</b> van hoog naar laag behandelprioriteit | ≈ 4 min   |
| 4                | Verfijnd observatiemodel | Selecteer exact 6 <b>EMA-items</b> (2 per behandel doel) uit de lijst van 20     | ≈ 4 min   |
| 5                | Mobiele coaching         | Schrijf een korte patientgerichte boodschap voor de app                          | ≈ 4 min   |
| Totaal (1 casus) |                          |                                                                                  | 20–25 min |

## Werkwijze – strikt te volgen

1. **Werk sequentieel: Deel 1 → Deel 5.** Ga pas naar een volgend deel wanneer het huidige deel volledig is afgewerkt.
2. **Gebruik geen generatieve AI, schrijfhulpmiddelen, richtlijnen of collegaoverleg.** Extern gebruik ondermijnt de methodologische validiteit en de blind scoringswaarde van de studie.
3. **Gebruik in latere delen uitsluitend de meegeleverde gestandaardiseerde context.** Die is bewust vastgezet zodat alle deelnemers op identieke input reageren en vergelijkbaar zijn.
4. **Herwerk eerdere antwoorden niet retroactief** nadat u latere context hebt gezien.
5. **Noteer of typ rechtstreeks in de voorziene antwoordzones.** Onleesbare of ambigu geformuleerde antwoorden bemoeilijken latere blinde beoordeling.
6. **Werk ook bij beperkte informatie.** Klinische teksten bevatten vaak onvoldoende informatie voor definitieve conclusies. Geef *altijd* een antwoord op basis van de beschikbare informatie en uw klinisch oordeel. Laat geen velden blanco zonder reden.

## 2 Deel 1: Operationalisering van de mentale gezondheidstoestand

### Instructies Deel 1

**Opdracht:** identificeer de belangrijkste actuele klacht- en toestandsdimensies (**symptomen**) in de klachttekst en noteer voor elke dimensie uitsluitend een **kort symptoomlabel**.

**Wat is een symptoom?** Een symptoom is een *klacht- of toestandsdimensie* die beschrijft *wat er mis gaat* bij de persoon. Het is *geen* behandeling, geen gedrag en geen oorzaak, maar een actuele toestandsbeschrijving:

- momenteel aanwezig bij de persoon (niet hypothetisch of anamnestic),
- onderscheidbaar van andere klachtdimensies (niet overlappend),
- in principe herhaald meetbaar via dagelijkse zelfrapportage (EMA),
- op DSM-5-TR/ICD-11-niveau: concreet genoeg om afzonderlijk te meten (bijv. “inslaapmoeilijkheden”, niet het brede “slaapstoornis”), maar niet te atomair (niet “wakker om 3u00” als apart symptoom).

**Voorbeelden van goede symptoomlabels:** inslaapproblemen, paniekepisoden, anticipatieangst, sombere stemming, emotionele uitputting, anergie, interpersoonlijke instabiliteit, compulsief controleergedrag.

**Let op:** gedragingen (bijv. “avondschermtijd”), oorzaken (bijv. “werkstress”) en behandelstrategieën zijn *geen* symptomen maar behandelingsopties – die horen in Deel 2.

**Antwoordformat:** label van 2–5 woorden, zonder beschrijvende zin. Noteer per casus **2–6 symptomen**. Laat ongebruikte velden leeg.

*Zie het uitgewerkte voorbeeld hieronder voor een concrete illustratie van wat een correct symptoomlabel is.*

### Hoe formuleert u een correct symptoomlabel?

**Klacht (verkorte versie):** “De afgelopen vijf maanden slaap ik slecht: ik lig lang wakker en word vroeg wakker. Overdag ben ik moe en prikkelbaar. Ik beweeg bijna niet meer en zie vrienden nauwelijks nog.”

**Correct ingevulde symptoomlabels** (elk één klachtdimensie, expliciet uit de tekst):

- **S-1** Inslaapmoeilijkheden (“lig lang wakker” → *afzonderlijk meetbaar*)
- **S-2** Vroegochtendontwaak (“word vroeg wakker” → *DSM-5-TR: early morning awakening; onderscheidbaar van S-1*)
- **S-3** Vermoeidheid overdag (“moe overdag” → *toestandsdimensie*)
- **S-4** Prikkelbaarheid (“prikkelbaar” → *emotioneel symptoom, los van S-3*)
- **S-5** Sociale terugtrekking (“zie vrienden nauwelijks” → *klachtpatroon*)

**Dit zijn GEEN symptoomlabels** (horen in Deel 2 als behandelingsoptie):

- “Weinig bewegen” → modificeerbaar gedrag, geen klacht; hoort bij Deel 2.
- “Slaapproblemen” → te breed: splits naar meetbare dimensies (zie S-1 en S-2).

## Casus 1: 41-jarige leraar secundair onderwijs

“Ik geef al vijftien jaar les en deed dat altijd graag, maar de voorbije maanden voel ik mij volledig leeg. Ik ga naar school, geef mijn lessen en kom thuis, maar er is niets meer over. 's Avonds zit ik voor de televisie en kan ik mij nergens toe aanzetten. Ik ben ook gestopt met afspreken met vrienden en reageer nog zelden op berichten. Op het werk begin ik fouten te maken – dingen vergeten, de draad kwijt raken tijdens een les – wat vroeger nooit gebeurde. Ik schaam mij daarvoor, maar ik weet niet hoe ik dit moet keren.”

### Uw antwoord

**Opdracht:** noteer **2–6 symptoomlabels** voor deze casus. Gebruik enkel korte labels (2–5 woorden); voeg geen beschrijving toe.

Symptoom 1 Label: \_\_\_\_\_

Symptoom 2 Label: \_\_\_\_\_

Symptoom 3 Label: \_\_\_\_\_

Symptoom 4 Label: \_\_\_\_\_

Symptoom 5 Label: \_\_\_\_\_

Symptoom 6 Label: \_\_\_\_\_

### 3 Deel 2: Initieel observatiemodel (bipartiet netwerk)

#### Instructies Deel 2

**Opdracht:** genereer **3–5** behandelingsoptielabels die samen het **initieel observatiemodel** voor deze casus vormen.

**Wat is een behandelingsoptie in deze context?** Een behandelingsoptie is een *modificeerbare gedrags- of procesvariabele* die beschrijft *wat de persoon kan veranderen*:

- **Modificeerbaar:** de persoon (of therapeut) kan er rechtstreeks op ingrijpen.
- **EMA-geschikt:** dagelijks meetbaar via een eenvoudige vraag op de smartphone (ja/nee, aantal, minuten of 0–10 schaal).
- **Causaal plausibel:** klinisch aannemelijk dat de behandelingsoptie de symptomen beïnvloedt.
- **Geen symptoom:** klachtniveaus of diagnostische trekken zijn *geen* behandelingsopties.

**Voorbeelden van goede behandelingsoptielabels:** avondschermtijd, geplande exposure, aerobe beweging, preslaap-offloading, veiligheidsgedrag, werk-privegrens, herstelactiviteit, compulsie-uitstel.

**Let op:** variabelen als “eetlust”, “spierspanning” of “moeheid” zijn klachtdimensies (symptomen) – geen behandelingsopties. Kies variabelen die de persoon actief kan uitvoeren of aanpassen.

**Antwoordformat:** enkel een label van 2–6 woorden, zonder meetdefinitie of toelichting. Laat ongebruikte velden leeg.

*Zie het uitgewerkte voorbeeld hieronder voor een concrete illustratie.*

#### Hoe genereert u behandelingsoptielabels?

**Gestandaardiseerde symptomen uit Deel 1 (voorbeeld):** S-1: Inslaapmoeilijkheden; S-2: Vroegochtendontwaak; S-3: Vermoeidheid overdag; S-4: Prikkelbaarheid; S-5: Sociale terugtrekking.

**Correct ingevulde behandelingsoptielabels:**

- **BO-1** Avondschermegebruik (*modificeerbaar gedrag; EMA: minuten voor slapengaan*)
- **BO-2** Lichaamsbeweging (*modificeerbaar; EMA: minuten actief bewegen per dag*)
- **BO-3** Sociaal contact (*modificeerbaar; EMA: ja/nee contact gezocht op eigen initiatief*)

**Dit zijn GEEN behandelingsopties** (zijn symptomen, horen in Deel 1):

- “*Vermoeidheid*” → klachtdimensie (= S-2), geen behandeldoel.
- “*Slechte slaap*” → klachtdimensie (= S-1), geen behandeldoel.

## Casus 1: 41-jarige leraar secundair onderwijs – Deel 2

41-jarige leraar secundair onderwijs; duur: 7 maanden. Emotionele uitputting, professionele depersonalisatie, sociale terugtrekking en cognitieve fouten op het werk.

### Gestandaardiseerde symptomen uit Deel 1:

- S-1 Emotionele uitputting
- S-2 Professionele depersonalisatie
- S-3 Sociale terugtrekking
- S-4 Cognitieve fouten op het werk

### Uw antwoord

**Opdracht:** noteer **3–5 behandelingsoptielabels** voor een initieel observatiemodel. Zorg dat elk label later dagelijks via een mobiele app meetbaar kan worden gemaakt.

Behandelingsoptie 1 Label: \_\_\_\_\_

Behandelingsoptie 2 Label: \_\_\_\_\_

Behandelingsoptie 3 Label: \_\_\_\_\_

Behandelingsoptie 4 Label: \_\_\_\_\_

Behandelingsoptie 5 Label: \_\_\_\_\_

## 4 Deel 3: Behandeldoelprioritering via het bipartiet netwerk

### Instructies Deel 3

**Opdracht:** rangschik de **5 gestandaardiseerde behandelingsopties** van **hoogste** naar **laagste** behandelprioriteit.

**Wat is een behandeldoel?** Een behandeldoel is de behandelingsoptie die, als zij veranderd wordt, naar verwachting de sterkste vermindering van de symptomen oplevert. Prioriteer op basis van monitoringbewijs (frequentie en ernst van het gedragspatroon), klinische modificeerbaarheid (haalbaarheid voor deze persoon) en netwerkimpact (invloed op meerdere symptomen).

**Het bipartiet netwerk lezen:**

- Behandelingsopties staan in de **linkerkolom (groen)**; symptomen in de **rechterkolom (blauw)**.
- **Blauwe rand:** positief verband (meer BO → meer S).
- **Rode rand:** negatief verband (meer BO → minder S).
- **Lijndikte:** proportioneel aan de sterkte van het verband (21-daagse EMA-data).

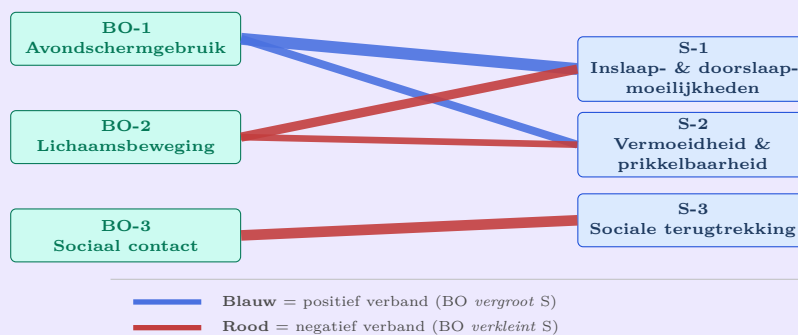
**Antwoordformat:** vul alle 5 prioriteitslijnen in, van rangorde 1 (hoogste) tot 5 (laagste).

*Zie het uitgewerkte voorbeeld hieronder voor een toelichting op de prioriteringslogica.*

### Hoe leest u het netwerk en rangschikt u de behandelingsopties?

**Monitoring (voorbeeld):** Schermtijd voor slapengaan: 18/21 avonden actief (gem. 65 min). Lichaamsbeweging: 0,8 sessies/week. Sociaal contact op eigen initiatief: 0,9/week.

**Bipartiet netwerk voor dit voorbeeld:**



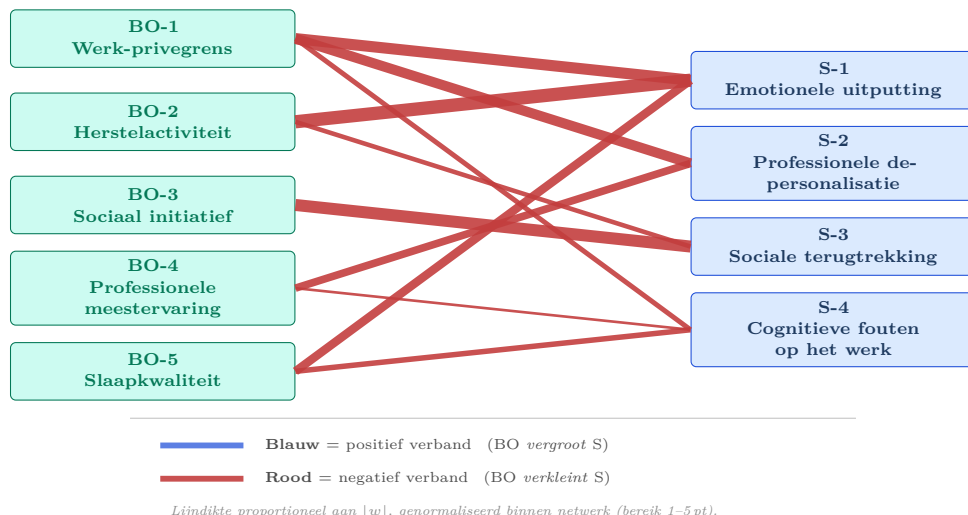
**Prioriteringsredenering (voorbeeld):**

1. **BO-1 (Avondschermsgebruik)** – raakt S-1 en S-2; monitoring toont 18/21 avonden hoog gebruik → **prioriteit 1**.
2. **BO-2 (Lichaamsbeweging)** – beschermend voor S-1 en S-2; frequentie extreem laag → **prioriteit 2**.
3. **BO-3 (Sociaal contact)** – sterk negatief verband met S-3; laag (0,9/week) → **prioriteit 3**.

## Casus 1: 41-jarige leraar secundair onderwijs – Deel 3

Emotionele uitputting, professionele depersonalisatie, sociale terugtrekking en cognitieve fouten op het werk. Duur: 7 maanden.

**21-daagse monitoring:** Werkoverschrijding na werktijd: gem. 5,4 episodes/dag. Herstelactiviteiten: gem. 1,2/week. Sociaal contact op eigen initiatief: gem. 0,7/week. Professionele meestervaringen: gem. 0,9/dag. Slaapkwaliteit: gem. 4,1/10.



### Uw antwoord

**Opdracht:** rangschik alle 5 behandelingsopties van hoogste naar laagste behandelprioriteit. Beschikbare behandelingsopties: BO-1: Werk-privegrens, BO-2: Herstelactiviteit, BO-3: Sociaal initiatief, BO-4: Professionele meestervaring, BO-5: Slaapkwaliteit

|              |       |
|--------------|-------|
| Prioriteit 1 | _____ |
| Prioriteit 2 | _____ |
| Prioriteit 3 | _____ |
| Prioriteit 4 | _____ |
| Prioriteit 5 | _____ |

## 5 Deel 4: Verfijnd observatiemodel – selectie van sub-behandelingsopties

### Instructies Deel 4

**Opdracht:** selecteer per casus **exact 6 EMA-items: 2 sub-behandelingsopties per behandel-doel** (3 behandeldoelen  $\times$  2 = 6 items).

**Wat zijn sub-behandelingsopties?** De gestandaardiseerde behandeldoelen in dit deel zijn *abstracte domeinen* (bijv. “Slaapkwaliteit” of “Voedingskwaliteit”). Om dit domein dagelijks via EMA te monitoren, moet het vertaald worden naar *concrete, specifieke gedragsitems* – de **sub-behandelingsopties**.

**Hoe werkt de abstracte-naar-concrete vertaling?**

- Een abstract behandeldoel beschrijft een *gedragsdomein* (bijv. Slaapkwaliteit, Voedingskwaliteit).
- Een sub-behandelingsoptie is de *concrete gedragsoperationalisering* van dat domein: een specifiek, dagelijks meetbaar item dat het domein direct meet (bijv. “schermvrij interval voor slapengaan (min)” als sub-optie van “Slaapkwaliteit”, of “gezonde maaltijd genuttigd (ja/nee)” als sub-optie van “Voedingskwaliteit”).
- Selecteer per behandeldoel de 2 items die het domein het *meest direct en precies* meten.
- Vermijd items die het domein slechts *zijdelings* raken.

**Belangrijk:** alle 20 items zijn behandelingsoptie-type EMA-items (modificeerbare gedragingen – *geen* symptomen).

**Antwoordformat:** vink **exact 6** items aan. Geen toelichting vereist.

*Zie het uitgewerkte voorbeeld hieronder voor een concrete illustratie.*

*Hoe selecteert u de meest passende EMA-items per behandeldoel?*

**Gestandaardiseerde behandeldoelen (abstract, voorbeeld):**

1. Slaapkwaliteit
2. Lichamelijke activiteit
3. Sociaal contact

**Selectielogica – hoe kiest u de 2 beste items per doel?**

Stel: doel 1 = *Slaapkwaliteit*. In de lijst staan o.a.:

- ✓ “Schermvrij interval direct voor slapengaan (min)” → **juist** (directe operationalisering)
- ✓ “Vaste bedtijd aangehouden (ja/nee)” → **juist** (complementaire meting: regelmaat)
- × “Cafeïne-inname na 15.00 uur (aantal)” → **niet juist** (raakt slaap slechts zijdelings, hoort niet bij Slaapkwaliteit)
- × “Maaltijd op vaste tijden (ja/nee)” → **niet juist** (hoort bij Voedingskwaliteit, niet bij Slaapkwaliteit)

Correct ingevuld (6 items totaal):

- Doel 1 → “Schermvrij interval voor slapengaan (min)” + “Vaste bedtijd aangehouden (ja/nee)”
- Doel 2 → “Duur actieve beweging vandaag (min)” + “Beweegactiviteit uitgevoerd (ja/nee)”
- Doel 3 → “Bewust sociaal contact gezocht vandaag (ja/nee)” + “Sociale activiteit bijgewoond of gepland (ja/nee)”

## Casus 1: 41-jarige leraar secundair onderwijs – Deel 4

### Gestandaardiseerde behandeldoelen (abstract) voor Deel 4:

1. **Werkgrenzen en mentale ontkoppeling** (*domein: stoppen met werk na werktijd; frequente overschrijding (5,4 episodes/dag)*)
2. **Herstel en ontspanning buiten werk** (*domein: actief herstelgedrag na werk; kritisch laag niveau (1,2/week)*)
3. **Professionele competentie-ervaring** (*domein: bewust opmerken en benutten van professionele succesmomenten; kan depersonalisatie temperen*)

### Uw antwoord

**Opdracht:** selecteer **exact 6** EMA-items (2 per behandeldoel) die het best aansluiten als sub-behandelingsopties. *Alle 20 items zijn dagelijkse mobiele EMA-items (behandelingsoptie-type, geen symptomen). In het Word-document kunt u de vakjes (□) omcirkelen of markeren in plaats van aanvinken.*

1. ☐ Bewust sociaal contact geïnitieerd buiten werkverband (ja/nee)
2. ☐ Werkmail of -berichten bewust niet gecheckt na werktijd (ja/nee)
3. ☐ Bewust contact met collega of leerling buiten leslokaal gezocht (ja/nee)
4. ☐ Werkgerelateerde gedachten actief afgesloten via vaste afsluiting na werk (ja/nee)
5. ☐ Cafeïne-inname na 15.00 uur (aantal)
6. ☐ Maaltijd als zelfzorgmoment op vaste tijd genuttigd (ja/nee)
7. ☐ Ochtendactiviteit voor aanvang werk uitgevoerd (bijv. wandeling, yoga) (min)
8. ☐ Herstelactiviteit buiten het werk actief uitgevoerd (min)
9. ☐ Consistent slaaptijdstip aangehouden (ja/nee)
10. ☐ Bewuste stap gezet om werkachterstand te reduceren (ja/nee)
11. ☐ Herstelactiviteit ingepland voor de volgende dag (ja/nee)
12. ☐ Lichaamsbeweging als herstelactiviteit na werk (min)
13. ☐ Alcoholinname vanavond (eenheden)
14. ☐ Moment van professionele positieve prestatie bewust opgemerkt (ja/nee)
15. ☐ Schermtijd in de late avond bewust beperkt (min)
16. ☐ Aantal nieuwschecks in de avond beperkt (aantal)
17. ☐ Professionele vaardigheid of aanpak bewust en succesvol ingezet (ja/nee)
18. ☐ Waterinname vandaag (glazen)
19. ☐ Aantal lessen vandaag (uren)
20. ☐ Digitale ontgiftiging (schermvrij uur in de avond) toegepast (ja/nee)

**Totaal geselecteerd:** \_\_\_\_\_ / 6

## 6 Deel 5: Gepersonaliseerde mobiele coachingsboodschap (HAPA-kader)

### Instructies Deel 5

**Opdracht:** schrijf een korte, rechtstreeks tot de persoon gerichte coachingsboodschap die in de mobiele applicatie verschijnt.

**Theoretisch kader – HAPA:** PHOENIX gebruikt het **Health Action Process Approach (HAPA; Schwarzer, 1992)** om de boodschap af te stemmen op de motivationele fase van de persoon:

- **Pre-intentionele fase:** de persoon is nog niet gemotiveerd om te veranderen → focus op risicobewustzijn en uitkomstverwachting.
- **Intentionele fase:** de persoon wil veranderen maar heeft nog geen concreet plan → focus op doelstelling en actieplanning.
- **Actie-/onderhoudsfase:** de persoon probeert al te veranderen → focus op copingplanning en zelfeffectiviteitsondersteuning.

U hoeft de fase niet expliciet te benoemen; gebruik het kader om de toon en inhoud van uw boodschap te sturen.

**De boodschap voldoet aan:**

- **Lengte:** 2–4 zinnen, compact genoeg voor een mobiel scherm.
- **Toon:** warm, direct, professioneel – geen klinisch jargon of diagnostische labels.
- **Inhoud:** adresseert het primaire behandeldoel en de voornaamste barriere; bevat een concrete, eerstvolgende actie.
- **Perspectief:** tweede persoon (“jij” of formeel “u”).

*Zie het uitgewerkte voorbeeld hieronder voor een volledige illustratie.*

### Hoe formuleert u een effectieve coachingsboodschap?

#### Context (voorbeeld):

- Primair behandeldoel: avondschermggebruik verminderen
- Voornaamste barriere: gewoontekracht – schermgebruik is de enige manier om na het werk te ontspannen (lage zelfeffectiviteit)
- HAPA-fase: intentioneel (wil veranderen, maar heeft nog geen concreet plan)

#### Voorbeeldboodschap:

*“Je weet dat je avondschermd je slaap in de weg staat, maar het voelt nog als de makkelijkste manier om te ontspannen na een drukke dag. Leg vanavond je telefoon om 21.30 uur in een andere kamer en vul die laatste twintig minuten met iets anders – een boek, muziek, of gewoon even niets. Eén avond is genoeg om te merken dat het kan.”*

**Waarom werkt deze boodschap?** De boodschap erkent de barriere (gewoontekracht), geeft een concrete actie met tijdstip, verlaagt de drempel en vergroot de zelfeffectiviteit.

## Casus 1: 41-jarige leraar secundair onderwijs – Deel 5

**Primair probleem**

Uitgesproken werkgerelateerde uitputting met verlies aan betekenis en toenemende sociale terugtrekking.

**Behandeldoel**

Een duidelijke werk-priviegrens installeren en na het werk consequent herstelgedrag activeren.

**Voornaamste barriere**

Actieplanning ontbreekt: er is geen concreet moment of signaal waarop de werkmodus stopt.

**Copingstrategie**

Koppel een vaste afsluitsignalering aan een kleine herstelactiviteit die onmiddellijk na het einde van de werkdag start.

**Uw antwoord**

**Opdracht:** schrijf hieronder de mobiele coachingsboodschap voor deze casus. *Formuleer alsof de tekst morgen rechtstreeks op de smartphone van de persoon verschijnt.*

---

---

---

---

## 7 Afronding en terugbezorging

---

Dank u voor het invullen van alle vijf delen voor uw toegewezen casus.

### Checklist voor terugbezorging

- ☐ Ik heb in Deel 1 symptoomlabels ingevuld.
- ☐ Ik heb in Deel 2 behandelingsoptielabels ingevuld.
- ☐ Ik heb in Deel 3 alle 5 behandelingsopties gerangschikt.
- ☐ Ik heb in Deel 4 exact 6 EMA-items geselecteerd.
- ☐ Ik heb in Deel 5 een mobiele coachingsboodschap geschreven.
- ☐ Mijn antwoorden weerspiegelen mijn eigen klinische oordeel zonder gebruik van generatieve AI of andere externe hulp.
- ☐ Ik begrijp dat mijn antwoorden geanonimiseerd worden voor analyse.

Bezorg het ingevulde document terug via e-mail aan:

`stijn.vanseveren@ugent.be` met onderwerp: PHOENIX-PRE-HCP-PRE-03

Na ontvangst worden uw antwoorden geanonimiseerd en opgenomen in het expertreferentiecorpus voor de latere blind evaluatie van PHOENIX. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit onderzoek.